

02/08

10h

INDICADO POR: Dr.<sup>o</sup> Carolina Ruston

(X) ACOMPANHAMENTO ( ) CONSULTA

NS

**ADRIANA FERREIRA DE FARIA**IDADE: 52 | PESO: 92 | ALTURA: 160 | PROFISSÃO: *Journalista*SINTOMAS: *Dor de cabeça / m. MIT edemaciado /*  
*Nos últimos 10 anos (↑ 30kg) / Depressão (Pai e mãe rancor)*QUEIXAS: *Dorme pouco (sono leve).*MEDICAMENTOS: *Desvi (intermitente, uso)*  
*Pré diabética / Asmática / Dor lombar*

MÉDICO:

MARCAPASSO: ( ) S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ( ) S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: *(2x semana)*HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: *18* JANTAR: SHORA QUE DORME: *não tem horário (na)* HORA QUE ACORDA: 4:30 *(20)* *após*COCHILHO: ( ) S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S ( ) N ( ) EVENTUALMENTE *não*TEM FILHOS: *X* S *X* N / DORMEM NO QUARTO: (X) S (X) N PET NO QUARTO: *X* S ( ) NBEBIDA ALCOÓLICA: ( ) S ( ) X NA SEMANA ( ) N *Sim (Fs)* *não faz boquete*FUMO: *X* S ( ) MAÇO/DIA ( ) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: *(5a 6 cigarros)*TIPO DE RESPIRAÇÃO: *narina D obstruída* BANHEIRO/NOITE: *1 à 2x*CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *↑* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:OVERLAP: *Asma* MALLAMPATI: IAH: 46 SPO2: 76% - média 92%<sup>1</sup>PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *Desvio de septo (E). PLM??**Dor lombar / Hipertrofia de amígdalas*CIRURGIAS: (S) NASAL ( ) AMIGDALECTOMIA *Desvi*

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA ( ) OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: ( ) S (X) N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

*19/07 Avaliação (imprimir PSG) (whats)**2.5* *Asma**26/07 online ↓ Auto 5 à 8 cmH<sub>2</sub>O. Ac: 8,5 22/07**2025 " P Fixa: 5,6 cmH<sub>2</sub>O. 24/07**↓ P: 5,6 cmH<sub>2</sub>O. ↓ pressão boca seca; oriento ex. língua**± AH = 3,2 e/h (Ac 2,2) ↑ amadif. G.**muco = 2h36' ↓ P: 5,4 cmH<sub>2</sub>O**fluxo = 15.1/min silva*



## POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: ADRIANA FERREIRA DE FARIA

Sexo: Feminino

Data do Exame: 07-06-2025

Idade: 52 anos

Peso: 92 kg

Altura: 1,60 m

Médico Solicitante: DRA. CAROLINA DE REZENDE  
RUSTON DAHER

### RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 07/06/2025 21:52 e finalizado às 08/06/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de 3,5 min e a latência para o sono REM de 266,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 276,5 min, com eficiência do sono de 58,8 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,8 % de estágio N1, 44,8 % de estágio N2, 40,7 % de estágio N3 e 10,7 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 190,3 min. Ocorreram 30 despertares, sendo o índice de 3,8 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 212, sendo 101 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 111 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 46,0 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 36,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 47,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 46,0 (nº/h), sendo 21,9 apneia/h e 24,1 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO<sub>2</sub>) basal foi 94%, a média de 92% e a mínima de 76%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 20,9 (nº/h), sendo que em REM foi de 46,8 (nº/h) e em NREM foi de 34,0 (nº/h). Permaneceu 3,7 % do tempo total de sono com SAO<sub>2</sub> abaixo de 90%.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório **(46,0 n°/h)** (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina **(76%)**;
3. Latência para o início do sono **(3,5 min)** (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM **(266,0 min)** (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono **(58,8 %)** (VN=  $\geq 85\%$ );
6. Índice de despertares **3,8 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 **(3,8 %)** (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 **(44,8 %)** (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta **(40,7 %)** (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM **(10,7 %)** (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

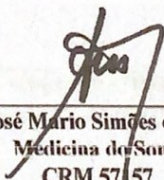
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

**Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.**

IAH: 05-15 /hora leve.  
IAH: 15-30 /hora moderada.  
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
**Dr. José Mario Simões da Costa**  
Medicina do Sono  
CRM 57.57